

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN VIH

Adrián Argüelles Curto, Beatriz Cuesta, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

La profilaxis postexposición al VIH (PEP) surge como una nueva herramienta frente a la lucha contra el virus, aportando una opción ante determinadas situaciones que pueden cursar con riesgo de contagio de la enfermedad.

Criterios de Inclusión

La transmisión del VIH puede realizarse únicamente por exposición a fluidos potencialmente infectantes. El mayor riesgo es por sangre o fluidos que contengan sangre visible. También potencialmente infectantes el semen, las secreciones vaginales, los líquidos cefalorraquídeos, pleural, pericárdico, peritoneal, amniótico, y la leche humana. No se consideran la orina, heces, saliva, vómito, secreciones nasales, lágrimas, sudor ni esputo, si no contienen sangre visible. La probabilidad de transmisión del VIH dependerá fundamentalmente de:

- Tipo de exposición: la sexual con diferencia es la más prevalente en no ocupacionales.
- Estado de la fuente de infección: VIH positivos conocidos presentan mayor riesgo infección.
- Cantidad de virus en inóculo: pacientes evolucionados sin TARGA o pacientes con enfermedad aguda presentan una carga viral elevada.
- Individuo expuesto: lesiones en mucosas, infecciones transmisión sexual o no circuncidado aumentan el riesgo de infección. Riesgo considerable.

Tabla 1.- Riesgo estimado de infección tras exposición de VIH + sin uso de preservativo, rotura o mal uso del mismo

Riesgo considerable (0.8-3%)	Riesgo bajo (0,05-0,8%)	Riesgo mínimo (0,01-0,05%)	Riesgo despreciable o nulo (<0,01)
Recepción anal con eyaculación	Recepción vaginal Recepción anal sin eyaculación Penetración anal Penetración vaginal Sexo orogenital con eyaculación	Sexo orogenital sin eyaculación Sexo orogenital femenino	Besos Caricias Masturbación Contacto con secreciones de piel íntegra

Tabla 2.- Riesgo estimado de infección tras exposición de VIH desconocido, sin uso de preservativo, rotura o mal uso del mismo

Riesgo Bajo (0.05 – 0.8)	Riesgo Mínimo (0.01-0.05%)	Riesgo despreciable o nulo(<0.01)
Recepción anal con eyaculación	Recepción vaginal Recepción anal sin eyaculación Penetración anal Penetración vaginal Sexo orogenital	Besos Caricias Masturbación Contacto con secreciones de piel íntegra

Además hay que tener en cuenta la capacidad de infectividad de la persona fuente y la presencia de sangrado, menstruación, úlceras sangrantes o ITS.

TRATAMIENTO

Tratamiento profilaxis posexposición

- Si la persona con riesgo de exposición acude en las 72 primeras horas, intentar conseguir

toda la información posible de la persona fuente para valorar tratamiento.

- Tras exposición accidental, las heridas y piel expuestas han de ser lavadas con jabón. Si es un pinchazo NUNCA exprimir la zona de inoculación.
- Administrar la PEP antes de 24 horas y nunca después de 72 horas de la exposición de riesgo.
- Se administrará tratamiento en:
 - o Riesgo considerable: SIEMPRE si cumple criterios previos.
 - o Riesgo moderado o bajo: Valorar caso individualmente
 - o Riesgo despreciable o nulo: no se recomienda.
 - o En el caso de exposición de riesgo a VIH en una mujer gestante se deben seguir las mismas recomendaciones de PPE que en las no gestantes.
 - o En todos los casos de agresiones sexuales está indicado el uso de PEP

Esquemas para PEP

- TRUVADA [Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200mg] 1 vez al día + ISENTRESS [Raltegravir 400 mg] 2 veces al día.
- TRUVADA + TIVICAY [Dolutegravir 50 mg] 1 vez al día.

Aunque la duración óptima del tratamiento se desconoce, basándose en la bibliografía se establece una pauta de 28 días. Siempre bajo la supervisión del equipo de Medicina Interna y Farmacia Hospitalaria que realizarán los seguimientos posteriores pertinentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (Actualización enero 2015). Disponible en: <http://www.gesida-seimc.org/contenidos/guiasclinicas/2015/gesida-guiasclinicas-2015-tar.pdf>.
- Documento de Consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre Sida respecto a profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños.
- Saag, M., Chambers, H., Pavia, A., Eliopoulos, G., Gilbert, D. and Sanford, J. (n.d.). The Sanford Guide to HIV / AIDS Therapy, 2017.